SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Khoa: ……

PHIẾU BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH GIỮA CÁC CA TRỰC
THEO ISBAR

BM-C6.1-04
Kèm SOP-C6.1-02
Trang ……/……

Ngày ……/……/20…… Giao ca: ☐ Sáng → Chiều ☐ Chiều → Đêm ☐ Đêm → Sáng Giờ bàn giao: ……h…… Mô hình phân công: ☐ Toàn diện ☐ Theo nhóm ☐ Tạm theo nhiệm vụ

Tổng NB	**NB cấp I**	**NB mới vào**	**Chuyển đến**	**Chuyển đi / ra viện**	**Đi PT, thủ thuật**	**Tử vong / nặng xin về**	**NB cần chú ý đặc biệt (số giường)**

Buồng/ giường	I – Xác định NB Họ tên, tuổi / mã NB ☐ Đã đối chiếu ≥ 2 yếu tố với vòng tay	S – Tình trạng hiện tại Chẩn đoán, cấp CS, DHST, ý thức, diễn biến trong ca	B – Bối cảnh Ngày vào/ngày điều trị, tiền sử, dị ứng, PT/thủ thuật, đường truyền, ống dẫn lưu	A – Nhận định ĐD Nguy cơ: té ngã (Morse), loét tì đè, NEWS2, suy dinh dưỡng, tâm lý	R – Đề xuất, việc cần làm Y lệnh chờ, XN/CLS chờ, thuốc giờ tới, theo dõi gì, báo BS khi nào	ĐD giao / ĐD nhận (ký)

Ghi chú: ghi theo từng NB, ưu tiên NB cấp I, NB mới, NB nặng; NB ổn định có thể ghi "Ổn, không thay đổi" ở S–A. Không ghi tắt ngoài danh mục viết tắt của khoa.

PHẦN BÀN GIAO CHUNG CỦA CA

Nội dung	Số lượng / tình trạng	Ghi chú, tồn tại	Đã kiểm đếm
Thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất (tủ trực, sổ theo dõi)			☐
Thuốc, dịch truyền, vật tư tiêu hao tủ trực			☐
Thiết bị: monitor, bơm tiêm điện, máy hút, bình oxy, xe cấp cứu (niêm phong)			☐
Hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc, y lệnh chưa thực hiện			☐
Việc chưa hoàn thành, hẹn giờ (XN, CLS, hội chẩn, chuyển viện)			☐

Kiểm tra cuối bàn giao (người nhận ca tự đánh dấu):

☐ Đã bàn giao tại giường với NB cấp I, NB mới, NB nặng

☐ Người nhận đã nhắc lại các việc ở mục R, hỏi lại điểm chưa rõ

☐ NB và người nhà được giới thiệu ĐD nhận ca

☐ Đã xem xong bảng phân công chăm sóc ca mới (BM-PCCS-01)

ĐIỀU DƯỠNG GIAO CA	ĐIỀU DƯỠNG NHẬN CA	ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)	**(Ký, ghi rõ họ tên)**	**(Kiểm tra, ký)**

Phiếu lưu tại khoa cùng sổ bàn giao 12 tháng (Cần xác minh thời hạn lưu theo quy định lưu trữ của Bệnh viện). ĐDT dùng BM-C6.1-01 để chấm ngẫu nhiên lượt bàn giao.

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU VÀ VÍ DỤ

Thành phần	Cần nói / ghi	Ví dụ (người bệnh giả định)
I – Identify **Xác định**	Người giao, người nhận; họ tên, tuổi/năm sinh hoặc mã NB, đối chiếu ≥ 2 yếu tố với vòng tay (SOP-D2.4)	"Em là ĐD A giao ca cho chị B. Giường 12, NB nam 68 tuổi, mã NB …, đã đối chiếu vòng tay."
S – Situation **Tình trạng**	Chẩn đoán, cấp chăm sóc, DHST mới nhất, ý thức, vấn đề chính trong ca	"Viêm phổi, chăm sóc cấp I. 14h: M 102, HA 100/60, SpO_2 93% thở oxy 3 lít/phút, sốt 38,6°C, tỉnh."
B – Background **Bối cảnh**	Ngày điều trị, tiền sử liên quan, dị ứng, thủ thuật, đường truyền, ống thông	"Ngày thứ 3 điều trị, tiền sử ĐTĐ type 2, dị ứng penicillin. Kim luồn tay trái ngày 2, sonde tiểu ngày 1."
A – Assessment **Nhận định**	Nhận định của ĐD, các nguy cơ đã đánh giá (Morse, Braden, NEWS2), mức lo ngại	"NEWS2 = 5, tăng so với sáng. Morse 55 – nguy cơ té ngã cao. Ăn kém."
R – Recommendation **Đề xuất**	Việc cần làm, y lệnh chờ, giờ dùng thuốc, theo dõi gì, ngưỡng báo bác sĩ	"Đo DHST mỗi 2 giờ, báo BS nếu SpO_2 < 92% hoặc HA tâm thu < 90. 18h kháng sinh liều 2. Chờ kết quả cấy máu. Giữ thanh chắn giường."

Lưu ý: ví dụ chỉ để minh hoạ cách nói, không phải dữ liệu NB thật. Ngưỡng báo bác sĩ theo y lệnh và quy định của từng khoa.

THẺ BỎ TÚI ISBAR (cắt theo khung, ép plastic)

BV ĐA KHOA NHẬT TÂN – BÀN GIAO ISBAR I Ai giao, ai nhận? NB nào? Đối chiếu ≥ 2 yếu tố S Đang có vấn đề gì? DHST, ý thức, cấp CS B Bối cảnh: tiền sử, dị ứng, ống, đường truyền A Tôi nhận định gì? Nguy cơ? NEWS2/Morse R Cần làm gì, khi nào, báo BS lúc nào? → Người nhận nhắc lại mục R	BV ĐA KHOA NHẬT TÂN – BÀN GIAO ISBAR I Ai giao, ai nhận? NB nào? Đối chiếu ≥ 2 yếu tố S Đang có vấn đề gì? DHST, ý thức, cấp CS B Bối cảnh: tiền sử, dị ứng, ống, đường truyền A Tôi nhận định gì? Nguy cơ? NEWS2/Morse R Cần làm gì, khi nào, báo BS lúc nào? → Người nhận nhắc lại mục R